

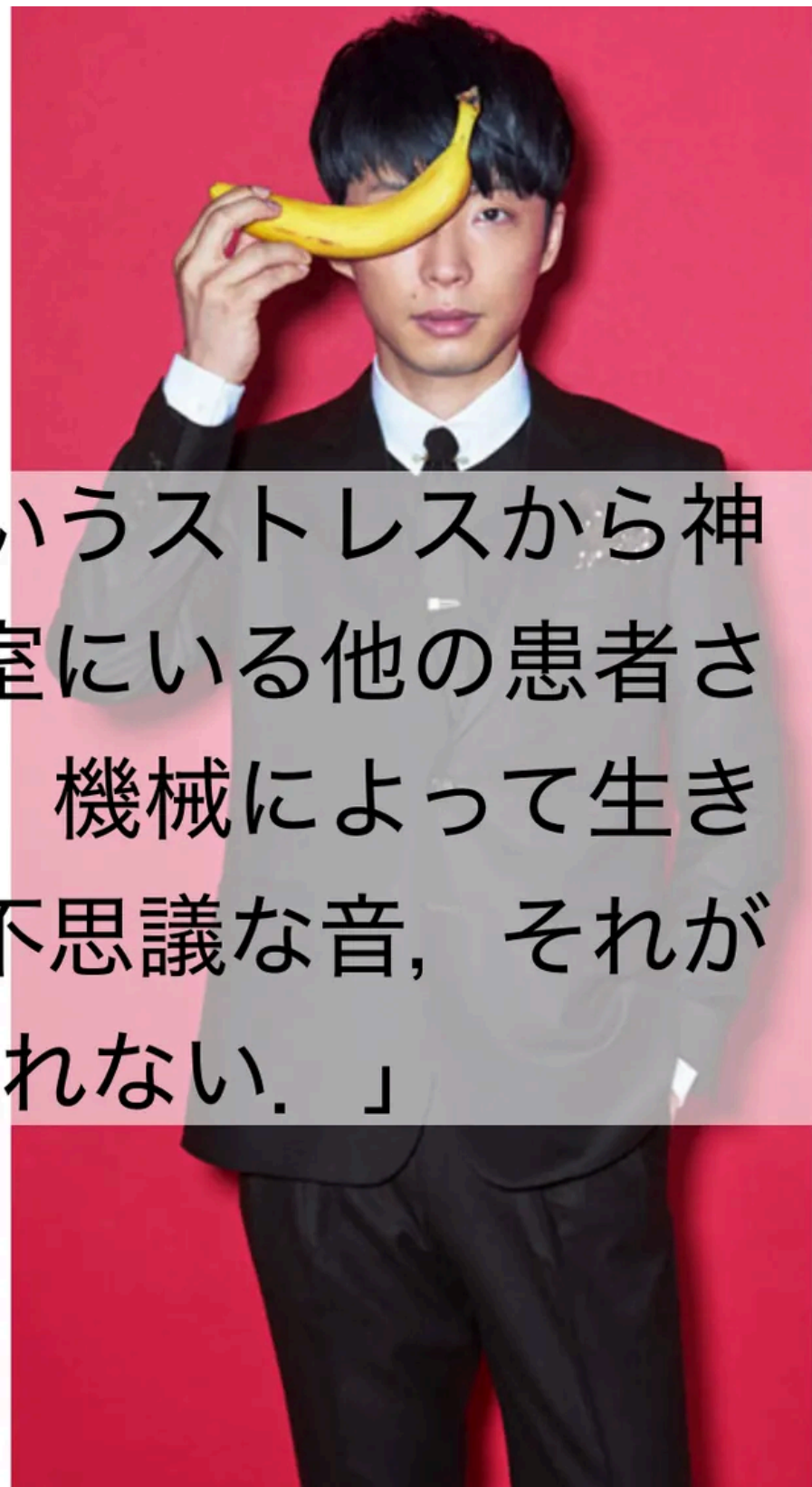
A photograph of a patient's hand in a hospital bed, with medical equipment and tubes visible in the background. The image is overlaid with a dark blue gradient.

ICUの人的ケア

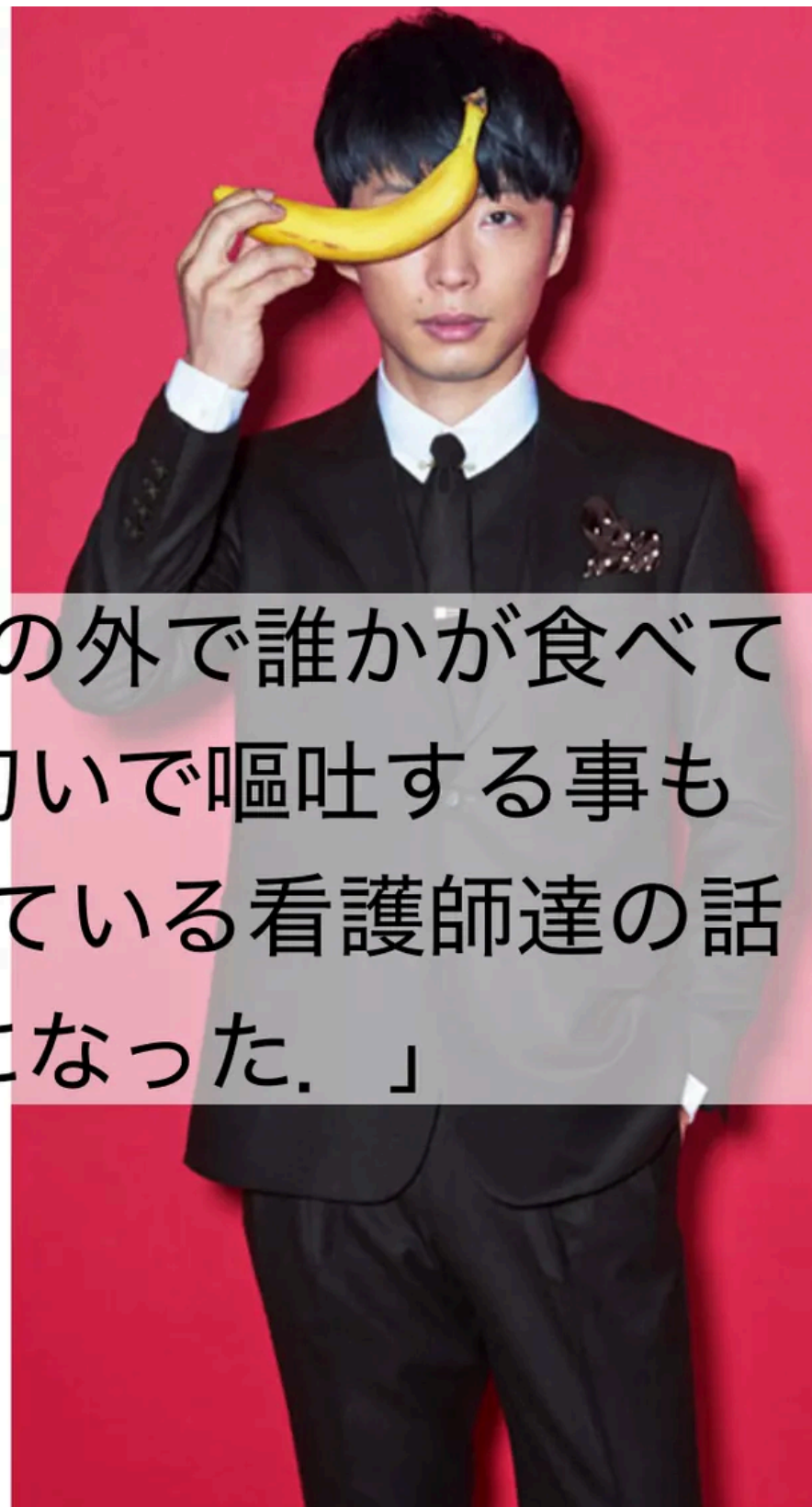
Human care を積み重ねて、ICUを Humanization する



「体が動かせなくなるというストレスから神経過敏になり，集中治療室にいる他の患者さんのうめき声，息づかい，機械によって生きている患者さんから出る不思議な音，それが気になって全く眠れない。」

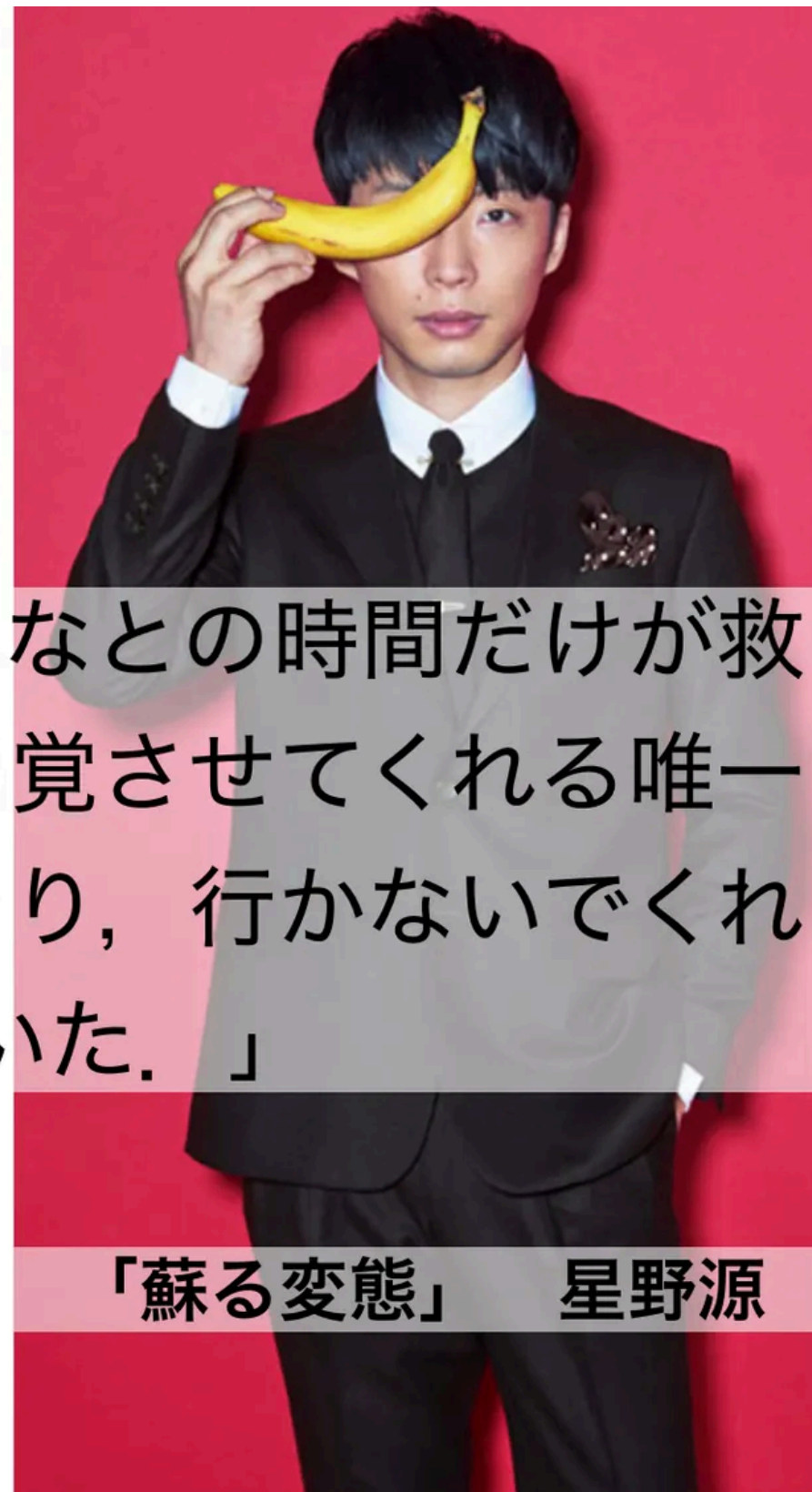


「時には深夜に集中治療室の外で誰かが食べて
いるであろうクッキーの匂いで嘔吐する事も
あった。 遠くの方で聴こえている看護師達の話
し声に発狂しそうになった。」



「お見舞いに来てくれるみんなとの時間だけが救
いだった。自分が何者かを自覚させてくれる唯一
の時間。皆が帰った後、ひとり、行かないでくれ
と声を殺して泣いた。」

「蘇る変態」 星野源



2つの言葉を分けて使う

Human care を積み重ねて、ICUを Humanization する

Humanization（目指す姿）

- 患者と家族を一人の人として尊重できるICUへ
- ケアだけでなく環境・仕組み・働き方まで
- ICU全体で整えていく考え方

Human care（日々の実践）

- 患者と家族を一人の人として尊重するケア
- 一人ひとりがベッドサイドで行う
- Humanizationを実現する手段

今日持ち帰る3つ

1

患者は起きている。聞けば苦痛は見える
口渇・不安・呼吸困難・睡眠を毎日尋ねる

2

善意は時刻表と実施率に落とす
「頼まれたらやる」は、ほぼ届いていない

3

家族と医療者も当事者
面会を開いて接点ごとに手当て。医療者のケアも人間化

最初に押さえる6つの数字

初日に口渇がある

66 %

症状で最多・最強

口渇を自分から訴えた

20 %

聞けば7割が答える

人工呼吸中の呼吸困難

約40 %

VASで平均45 mm

頼まれたら式の保湿

0.5 回/7時間

時刻表なら4.4回

ABCDEFと院内死亡

0.32 aHR

非ランダム化の関連

柔軟な面会の家族PTSD

21 %

通常の面会は30.5%

第 1 章

01

治療のフォーカス

臓器から、患者・家族・医療者へ

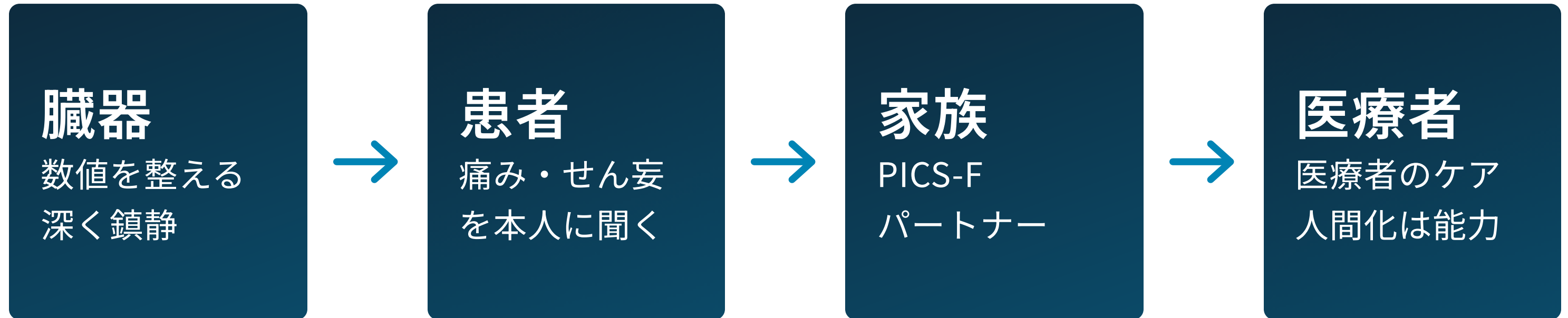


患者は何を語っているか

「人に囲まれていて、
これほど孤独になれるとは知らなかった」

「私は「4号室のあの患者」ではなかった」

フォーカスは、臓器から医療者へ広がった



PAD 2013 → PADIS 2018・2025

眠らせ方から、痛み・不穏・せん妄の管理へ

前の段を捨てない

質の高い医療の上に Human care が乗る

非人間化とは、人を「物」として扱うこと

患者が失うもの

- アイデンティティ
- 意思を伝える力
- 自分のことを伝える力
- 敬意とプライバシー

人間化の小さな実践

- 面会を開く・触れる
- 病気以外のことも話す
- せん妄の患者にも礼儀正しく
- 眼鏡・補聴器・口腔ケア

ICUの環境そのものが、非人間化を生みやすい

非人間化は、構造から生まれる

層	非人間的なケアを生む条件
社会・法制度	権利の否認、利益への関心、資源の不足
病院組織	断片化されたケア、ルーチン化、多重業務
個人	直接ケアの不足、患者の孤立、身体への偏り
くびれ	ベッドサイドに看護師がいること・情報提供

人間的なケアは「看護師だけの決断ではない」

国際的な枠組み：HU-CIの7領域

領域	中身
オープンドア	面会の開放。家族はケアのパートナー
コミュニケーション	チーム・患者・家族の対話、AAC
患者の well-being	痛み・口渇・寒さ・不眠・孤独・恐怖
医療者へのケア	燃え尽き・共感疲労・休む場所
PICS	退室後の不調の予防と早期発見
人間化された環境	自然光・プライバシー・居場所
終末期ケア	緩和ケアの統合、意思決定の支援

第2章

02

深鎮静の時代は終わった

起きている患者は、苦痛を伝えられる



深鎮静は「既定値」ではなく「例外」

深鎮静の害（18項目の例）

- 人との接触の喪失
- せん妄・ICU-AW
- 人工呼吸と滞在の延長
- 永続的な認知障害

深い鎮静が要る5場面

- 非同調を伴う重症呼吸不全
- 筋弛緩薬の使用
- てんかん重積
- 頭蓋内圧亢進の一部 など

人員不足は深鎮静の理由にならない

鎮痛を先に、鎮静は最小に、ケアは最大に

鎮痛を先に

多角的鎮痛で
オピオイド減



鎮静は最小に

RASS -1~0
ベンゾは限定



ケアを最大に

睡眠・離床
対話と面会

目指す姿は3C

Calm・Comfortable・Cooperative

興奮したら、まず原因

痛み・せん妄・非同調・便秘を探す

PADIS 2025：不安は新領域、推奨はまだない

問い	推奨（条件付き）	ポイント
鎮静薬	デクスメトミジンを提案	せん妄 RR 0.55、徐脈 RR 1.65
リハビリ	強化リハビリを提案	ICU-AW RR 0.77（high）
睡眠	メラトニンの投与を提案	睡眠時間は延びない
不安	推奨不能（根拠なし）	まず測ることから
せん妄	抗精神病薬は推奨不能	原因の除去と非薬物的ケア

起こした患者は、孤独と言えない苦しさを抱える

覚醒した患者の体験

- 言葉も道具も使えない
- 伝わらないと消耗する
- 人に囲まれていても孤独
- 病気以外の自分を見てほしい

1/4超

鎮静中断6時間後の重度の不安

伝えられないことが最悪の体験

人工呼吸の患者の語りの統合

起こすことは責任を引き受けること

次の章：聞いて、測る

第3章

03

聞かなければ存在しない

口渇・不安・呼吸困難・睡眠を尋ねる

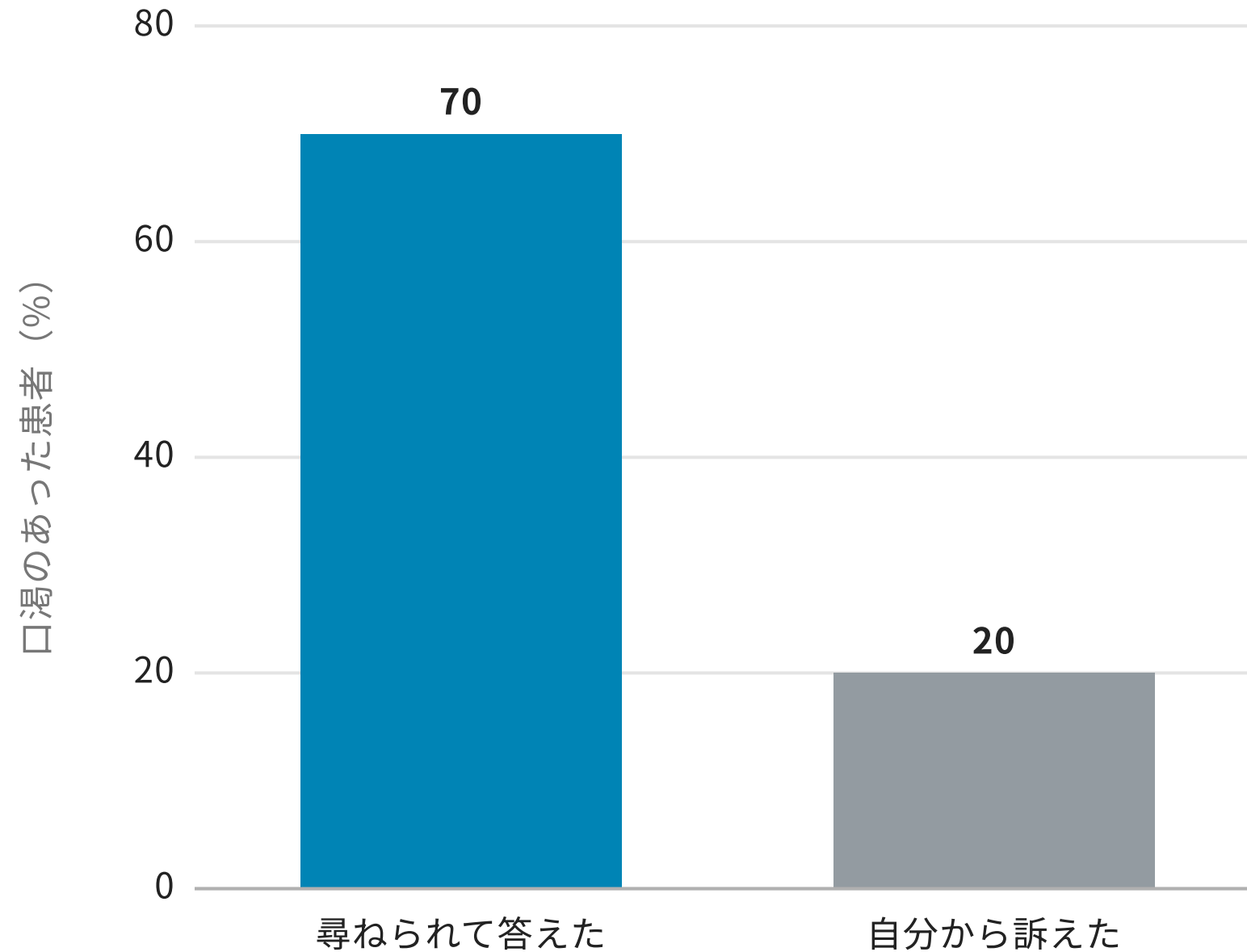


多いのは口渇、苦しいのは不安

指標	1位の症状	値
初日の有病率	口渇	66%
初日の平均の強さ（0～10）	口渇	6.13
7日間の有病率	口渇	64%
初日の平均の苦痛度（0～10）	不安	5.24
7日間の平均の苦痛度（0～10）	不安	5.46

強さだけで優先順位をつけると、不安を取りこぼす

口渇の8割は、聞かれて初めて出てくる



待っていると2割
聞けば7割が答える

ケアの効果は1時間
1時間で元に戻った

湿っていても渇いている
口渇と口腔の水分は無相関

毎日尋ねる5つ「iPad 2」

頭文字	訴え	聞き方の例
I	Insomnia（不眠）	夜は眠れましたか
P	Pain（痛み）	どこが、どのくらい痛みますか
A	Anxiety（不安）	怖い・落ち着かないことはありますか
D	Dry mouth（口渇）	喉が渇いていませんか
D	Dyspnea（呼吸困難）	息が苦しくありませんか

答えられない患者には、うなずき・文字盤・指差しで答えられる形で聞く

道具は、検証された集団で使う

測るもの	道具	注意
口渇	NRS 2問（強さ・苦しさ）	重度7～10。TDSはICU未検証
睡眠	RCSQ（日本語版あり）	総得点だけ。非挿管・せん妄なし
挿管患者	TOURS（4項目）	1日2回。転帰との関係は未検証
不安	Faces Anxiety Scale	推奨はまだない
呼吸困難	VAS・NRS	人工呼吸中の約40%

ICU患者の最大半数は答えられない。「測れなかった」も記録する

呼吸困難は、痛みと同じく緩和の対象

陽性なら探すこと

- 換気設定（非同調）
- 不安・痛み
- 分泌物・気道
- それでも残れば緩和

約40%

人工呼吸中に呼吸困難を報告

強さは VAS 45 mm

0～100 mm の平均

モニターの値が良くても苦しい

すべての患者で同定・予防・緩和

話せない患者に、伝える手段を渡す

渡す手段

- 眼鏡・補聴器・入れ歯を戻す
- はい／いいえの合図を決める
- 文字盤・筆談・タブレット
- 気管切開なら発声の手段

しないこと

- 患者の頭の上で話す
- 説明せずに処置する
- 患者の前で苦痛な発言
- 答えを急かす

非人間化は、コミュニケーションの場面で最も起きやすい

第 4 章

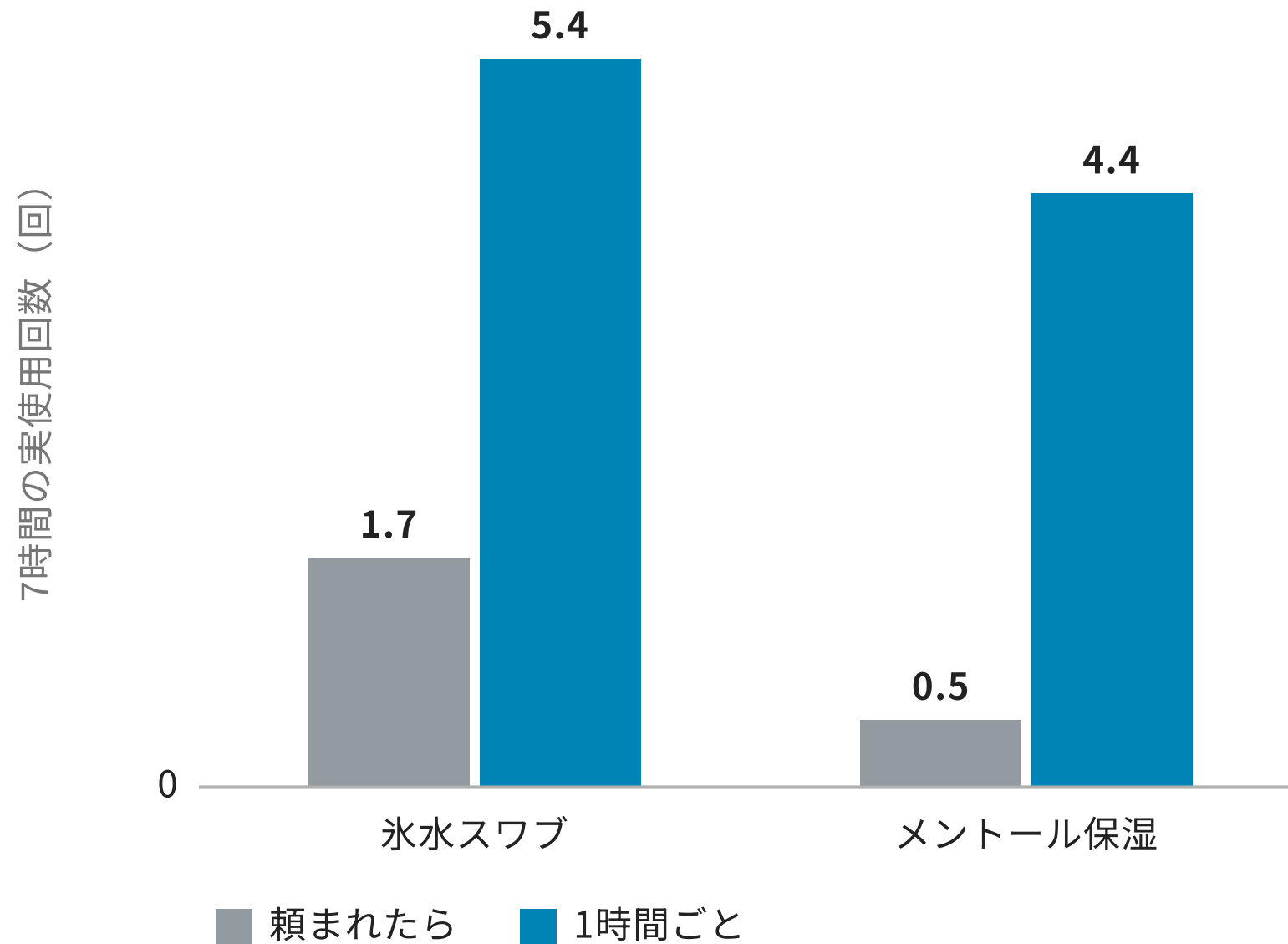
04

善意は時刻表に載せる

届いた割合が転帰を変える



「頼まれたらやる」は、ほぼ届いていない



0.5回

頼まれたら式の7時間の保湿

口渴の強さ -2.84 対 -1.68

P=.02、苦しさは有意差なし

非ランダム化・挿管例ほぼなし
強さを誇張しない

1時間で戻るから、1時間ごとに

研究	デザイン	主な結果
Puntillo 2014	RCT・252名	口渇 5.9→3.6（対照4.7）
Kalfon 2017	クラスターRCT	口渇 2.32 対 3.40
Zhang 2021	RCT・61名	口渇 6.69→5.42
Lemyze 2020	前後比較・26名	ミント氷で 8.5→4.0
Doi 2021	観察・86名	効果が保たれたのは1時間

口渇は消えない。答えは「時刻表に載せる」

ABCDEFは、届いた割合に比例して効く

アウトカム	完全実施（95%CI）
7日以内の院内死亡	aHR 0.32（0.17–0.62）
せん妄	aOR 0.60（0.49–0.72）
身体抑制の使用	aOR 0.37（0.30–0.46）
ICU再入室	aOR 0.54（0.37–0.79）
有意な痛みの報告	実施割合とともに増加

痛みの報告の増加は「見えるようになった」から

身体抑制は、監視すべき有害事象

抑制するなら記録

- 理由（行動か、予防か）
- 部位の数と総時間
- 誰が決めたか・指示
- 家族への説明

8%

抑制されていた患者

医師の指示があったのは52%

家族への通知の確認は38%

抑制の前に原因を探す

痛み・口渇・尿意・せん妄

第 5 章

05

人として扱う

つながりと、名前を呼ぶこと



人間的だと感じるのは「つながり」を感じたとき

誰の	主題
患者	医療者とのつながり：目を見る・微笑む・触れる
患者	自分とのつながり：情報・清潔ケア・整容
患者	外の生活とのつながり：ラジオ・花火
家族	唯一無二の人として世話されているのを見る
家族	そばにいる・触れる
家族	自分たちもケアされる

効いているのは高価な介入ではなく、小さなこと

ラインの奥に踏み出す



毎回やること

- 名乗り、呼ばれたい名前と呼ぶ
- 目線を合わせ、本人に向かって話す
- 処置の前に、何をするか伝える
- 日付・時刻・場所・予定を伝える
- 帰り際に「ほかに困りごとは」

その人を知るボードは、使って初めて効く

Get to Know Me Board

- 呼ばれたい名前
- 趣味・大切なもの
- 元気が出ること
- 回診でそれを見て話す

90%・99%

患者・家族が「重要」と回答

家族の85%が「名前」を有用

患者は28%

「誰も使わなかった」 17%

掛けてあるだけでは失敗

希望を叶える工夫は、受け入れられても効果は未確立

試みられていること

- 音楽（多くはヘッドホン）
- 動物の面会
- ICU専用のVR
- 家族の声をAIで再現（構想）

わかっていること

- 音楽の効果のエビデンスは限られる
- ペット面会は全工程2時間超
- VRは満足度8/10でも効果なし
- AIの声は有効性データなし

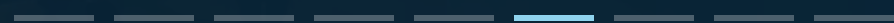
満足度は「受け入れられる」の指標で、「効く」の指標ではない

第 6 章

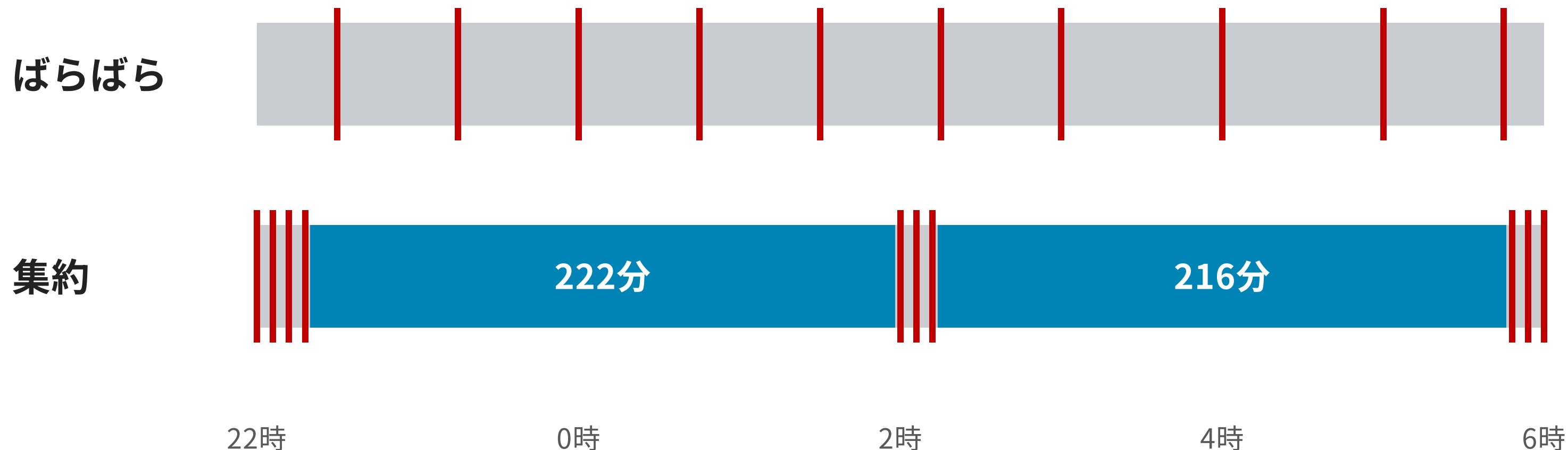
06

夜は静かに暗く

環境は単独でなくバンドルで



夜は、90分以上触らない時間をつくる



赤い線＝処置・観察で起こす ティール＝90分以上途切れない時間

同じ回数のケアでも、まとめれば眠れる

大きな音は、患者の耳のすぐ横から

今日確認できること

- アラーム音量が毎回標準に戻らないか
- 患者の頭の近くで申し送りしない
- 個室のドアの外で噂をしない
- 測るなら大きな音の回数

44～66.5 dBA

ICUの平均音圧（WHOは昼35）

ピークは申し送りと回診

100 dBA超が1時間に2回

騒音の半分以上は職員の声

単発の掲示や教育は元に戻る

単独の環境介入は、大規模RCTで陰性

介入・測定	わかっていること	言い方
夜の光	20 lux超が1時間に7～16回	暗闇の断片化を見る
日中の高照度光	734名のRCTで陰性	単独では効かない
メラトニン	予防847名で陰性・PADISは提案	環境を整えたうえで
耳栓・アイマスク	文献間で食い違う	バンドルの一部
睡眠覚醒調節薬	せん妄 RR 0.60・低確実性	全例には使わない

光・耳栓・静穏時間は、ばらばらでなくバンドルで

ICUの設計も治療の一部。約束は環境の指標まで

わかっていること

- 個室化で残響0.7→0.3秒
- 遮音0→21 dBA
- 測定は患者が入る前の空室
- 家族の居場所は best practice

提案するときは

- 何を測るかを着工前に決める
- 体験と環境の指標で約束する
- 家族と職員の居場所も同じ計画に
- 価値で定義する

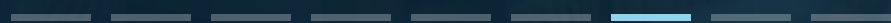
「せん妄が減ります」と言って予算を取らない

第7章

07

家族はケアのパートナー

面会を開き、接点に手当てを



PICS-Fは家族の20～60%、生活まで揺さぶる

家族に起きること

- 不安・抑うつ・PTSD
- 仕事を離れる
- 貯蓄を失う
- 時間では解決しないことも

20～60%

PICS-Fが起きる家族

1か月で44.9%が離職

1年で36.7%が貯蓄を失う

家族の約3割にPTSD症状

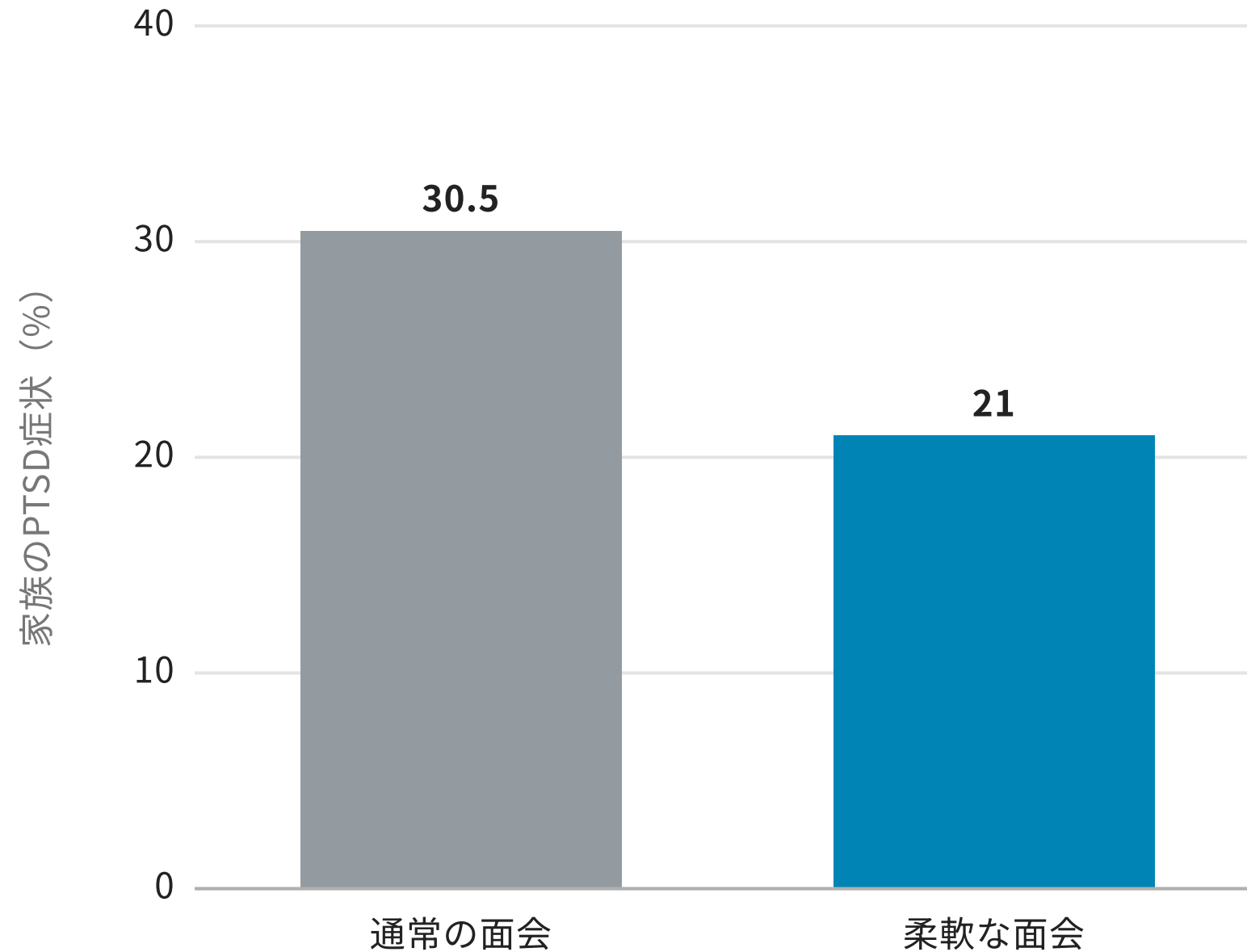
方針と指標は疾患と稼働だけ

面会の緩和が、唯一の「強い推奨」

ステートメント	強さ（確実性）
面会を緩和した方針をICUの既定とする	強い（low）
家族向けの教育プログラム	条件付き（moderate）
回診への同席・ケアへの参加	条件付き（low）
家族カンファの標準化とVALUE	条件付き（low）
家族向けの意思決定支援ツール	推奨せず

家族は visitor ではなく partner in care

柔軟な面会が効くのは、家族の心理



患者のせん妄は差なし

18.9% 対 20.1%

面会4.9時間 対 1.5時間

構造化ミーティングと冊子つき

感染・燃え尽きは増えない

時間だけ延ばすと外れうる

家族の引き金は、滞在の全体に散らばる

初回面会の前

チューブの本数・目が開いているか・抑制・むくみを予告

待っている間

家族自身の睡眠と食事を尋ねる

覚醒の前日

せん妄は起こりうる・一過性・人格ではないと伝える

看取り

モニター表示を消すかを選んでもらい、死戦期呼吸を先に伝える

一度の面談に頼らない

それぞれの接点に予告と説明を置く

面談はVALUEで

頭文字	すること
V Value	家族の言ったことの価値を認める
A Acknowledge	家族の感情に気づいていると伝える
L Listen	よく聴く
U Understand	患者がどんな人だったかを尋ねる
E Elicit	家族からの質問を引き出す

患者を人として語る一文と、家族の体調を聞く一文を

担い手を1人足しても、家族の心理は動かなかった

試験	足したもの	家族の心理
PARTNER	多職種チームの支援	差なし
FICUS	指名の家族ナース	8項目すべて差なし
ファシリテーター	看護師が3か月伴走	抑うつ差 -0.07点
Caregiver Pathway	4つの時点で接点	IES-R 6.8点低下

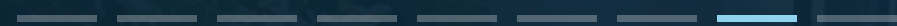
効いたのは面会を開くことと、接点を複数置くこと

第 8 章

08

ICUのあとと医療者

回復は続き、人間的なケアは能力



PICSは、入室の日から動く回復の過程

ゴールは生活に戻ること

- 家庭
- 趣味
- 仕事
- 家族と一緒に

64%

J-PICS：日本のICU患者のPICS

確実なのはICUにいる間の予防

浅い鎮静・せん妄予防・早期離床

退室時に4項目を手渡す

リハ・離床・栄養・残るリスク

ICUダイアリーの価値は、つながりにある

わかったこと

- 3か月PTSD 29.9% 対 34.3%
- 差なし（657例・P=0.39）
- 妄想的記憶38.5%がPTSDに
- 健忘にしてもPTSDは減らない

どう使うか

- 目的をPTSD予防にしない
- 記憶の補完と家族の支えに
- 医療者も人間化される
- 記憶を消す鎮静はしない

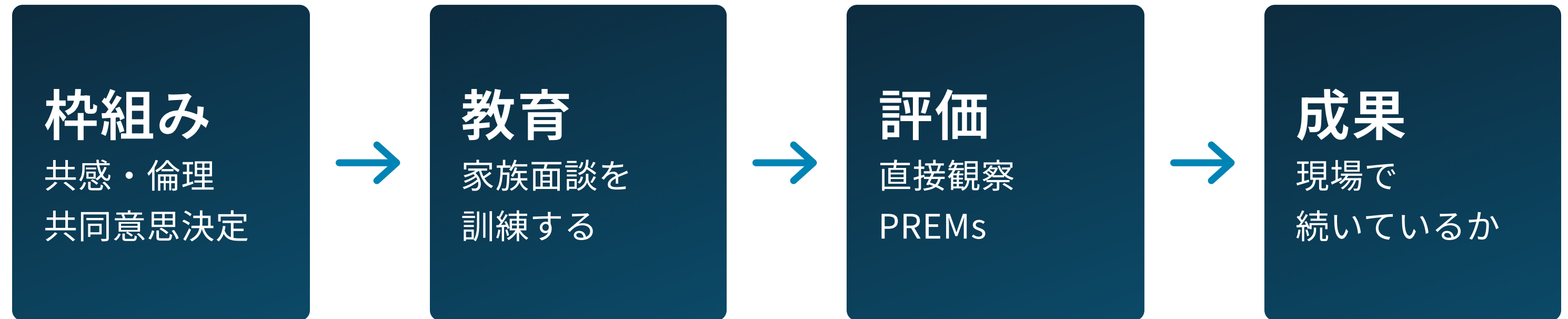
ダイアリーは「医療スタッフと患者の双方を人間化した」

医療者へのケア：共有する傷の5つの枠組み

頭文字	中身
A 家族を受け入れる	家族支援を職務の必須要素に
B 燃え尽きを防ぐ	個人の研修より、人員配置と心理支援
C 倫理的な風土	関係性の能力を訓練する
D 時間を確保する	時間は関係性ケアの通貨
E 励ます	守られた時間と研修の資金

疲れ切ったチームは、人間的なケアを届けられない

人間的なケアは、教えて評価する能力



家族面談をシミュレーション
急変対応と同じように多職種で

善意だけでは続かない
研修を受けた、で終わらせない

第9章

09

聖路加ICUの Hotel ICU

6つの柱と、ICUの前・中・後をつなぐケア



Hotel ICU：6つの柱

医療者へ

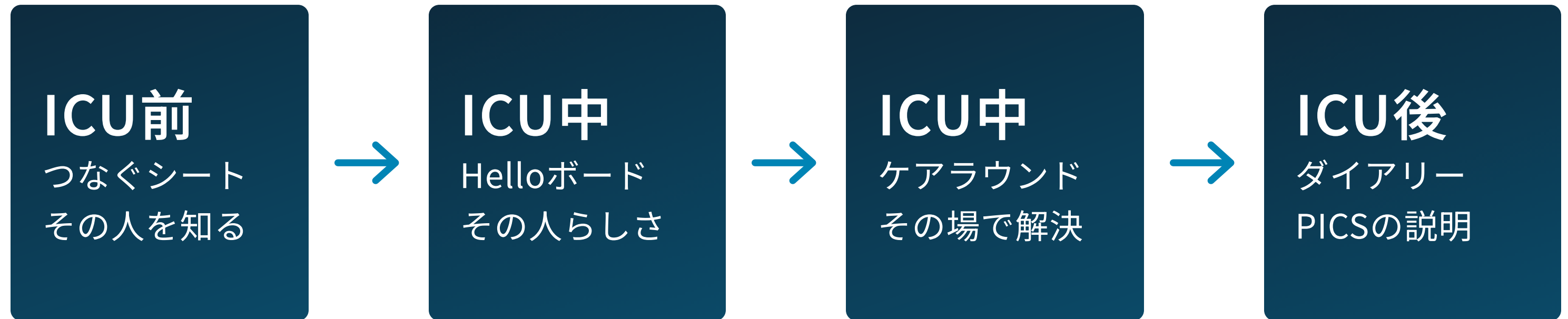
- 04 働きやすい環境
- 05 スタッフの Wellbeing
- 06 プロとしての満足感



患者さん・ご家族へ

- 01 ホスピタリティー
- 02 Human Care
- 03 質の高い医療

ICUの前・中・後をつなぐ4つの施策



いまの力点はケアラウンド
ICUにいる間の予防へ

文献との対応
その人を知るボード・日記

退室後訪問で聞いた声（2024年度）

多職種で訪問

22 人

4日以上の33人のうち

つらかったことがあった

13 人

呼吸に関する記憶が多い

口渇を覚えていた

約3 割

22人のうち7人

- 見えた限界：苦痛を知るのは、それが「過去のこと」になってから
- だから力点を、ICUにいる間の予防＝ケアラウンドへ移した

ケアラウンド：多職種で週2回、ベッドサイドへ

	どう回っているか
誰に	意思の疎通ができる方。せん妄・挿管中も対象
誰が	医師・看護師・薬剤師・栄養士・理学療法士の2人以上
いつ	週2回（月・金）。1人約10分
何を	30項目で見て、その場で介入し記録
翌日	受け持ち看護師が結果を評価

パイロットで最も多かった訴えは口渇。その場で対応できている

ICUを出たあとも、つながる

ICUダイアリー

- 人工呼吸24時間以上の見込みの方
- ICUの看護師が書き始める
- 病棟で本人に手渡し、記憶を伺う
- 渡せないときはご家族へ

PICSの説明

- パンフレットを患者さんにご家族へ
- 体・心・認知の不調を伝える
- 相談先を明記
- 院内のPICSチームで対応

文献どおり、ダイアリーは記憶の補完とつながりのために

言えること・言えないこと

介入	言えること	言えないこと
口渇ケア	口渇が下がる	せん妄が減る
ABCDEF	用量反応の関連	因果としての死亡減少
柔軟な面会	家族の心理の改善	患者のせん妄の減少
ICUダイアリー	家族・医療者とのつながり	患者のPTSD予防
環境・設計	環境の指標の改善	転帰の改善

効果が未証明でも、やらなくてよいわけではない

明日からの3つ

1

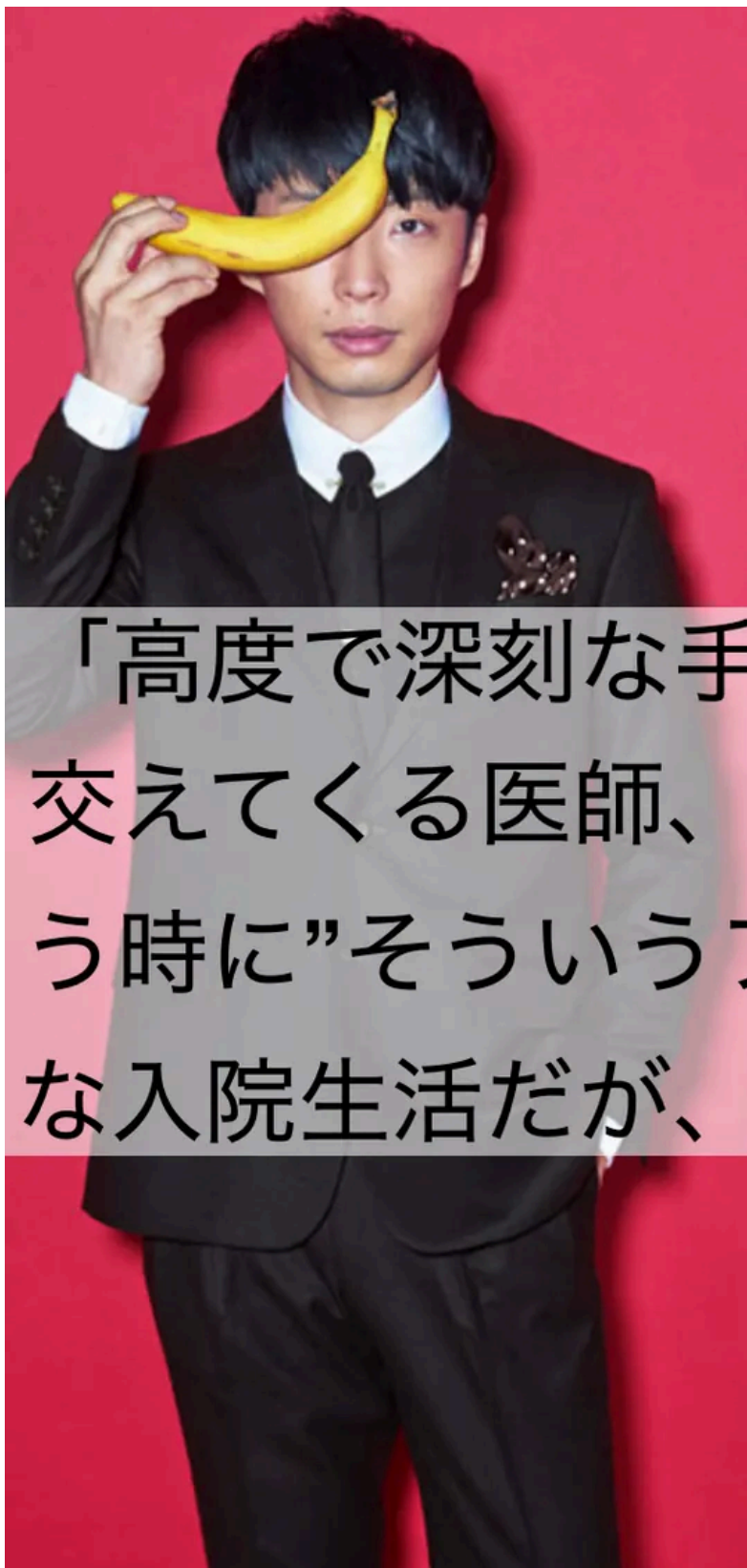
患者の声に耳を傾け、手を添える
毎日 iPad 2 を尋ね、口渇ケアを時刻表に

2

人として向き合う
名前を呼び、処置の前に声を掛ける

3

家族と仲間にも目を向ける
初回面会の前に予告。夜は90分触らない



「高度で深刻な手術内容を説明しながら下ネタを交えてくる医師、美人看護師に座薬を入れてもらう時に”そういうプレイだ”と妄想する自分。過酷な入院生活だが、**面白さが辛さに勝ったのだ。**」

確認クイズ：○か×か

Q1 柔軟な面会は、患者のせん妄を減らす

Q2 口渇は、聞かなくても患者が訴えてくれる

Q3 口が湿っていれば、口渇はない

Q4 ABCDEFは実施割合が高いほど転帰が良い

Q5 ICUダイアリーは患者のPTSDを防ぐ

確認クイズの答え

Q1 ✕ 効いたのは家族の不安・抑うつ・PTSD

Q2 ✕ 自分から訴えたのは20%だけ

Q3 ✕ 口渇と口腔の水分は相関しない

Q4 ○ ただし非ランダム化の関連

Q5 ✕ 657例のRCTで差なし

ご清聴ありがとうございました

元気とユーモアを忘れずに、Human care の実践を